

课程目标: 在相同任务下观察诊断课跑步损耗、诊断课站点损耗、站后下一跑变化和跑段平均心率变化。课程保留重复跑-站转换与站后跑步需求，但不是正式比赛的等比例、同顺序模拟。第一轮必须控速。

60分钟教案

每轮单独计时；任何排队或器械变化均标记污染

时间	内容	教练重点
0-4	签到与状态筛查	睡眠、腿部酸痛、疼痛、今日主观状态1-5分；状态评分不能替代医学筛查。
4-10	600-800m轻松跑 + 动态活动	髌、踝、胸椎、肩；同步观察步态、呼吸和疼痛反应。
10-14	专项激活	Ski 100m、轻雪橇推/拉各12.5m、BBJ 10m、Wall Ball 5次。
14-16	数据、动作标准与起跑顺序	说明两次Lap、污染标记、首轮控速和终止条件。
16-50	4轮连续混合疲劳主课	每轮记录跑步和站点总时间；记录技术异常、排队与器械变化。
50-55	400m慢跑/走 + 呼吸恢复	不追加冲刺、惩罚训练或临时加量。
55-60	汇总与反馈	先判断可比性，再判断瓶颈；课后20-30分钟补收整体session-RPE。

4轮主课与总量

每轮: 800m跑 → SkiErg 250m → 雪橇推12.5m → 雪橇拉12.5m → Burpee Broad Jump 20m → Wall Ball 15次。
四轮总量: 跑3.2km；Ski 1000m；雪橇推/拉各50m；BBJ 80m；Wall Ball 60次。

强度: 本课目标配速 = 预计HYROX比赛配速慢5-10秒/km。R1约7，R2为7-8，R3约8，R4最高8.5。前三轮目标±5秒/km（800m为±4秒）；第四轮不以最后200m冲刺掩盖前段崩溃。

立即停止: 胸痛/胸部压迫、晕厥或近晕厥、异常严重气短、意识或协调异常、锐痛或动作失控。启动现场应急流程；症状严重或持续时寻求紧急医疗帮助。任何心率数字都不能覆盖症状判断。

指标边界与来源: ΔHR = 平均(HR3,HR4)-HR1，只是混合课跑段平均心率变化，不是标准稳态心率漂移/解耦测试。HYROX比赛结构: <https://hyrox.com/the-fitness-race/> 官方备赛: <https://hyrox.com/best-hyrox-preparation/> 最新规则: <https://hyrox.com/rulebook/> session-RPE原始研究: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11708692/>

签到、起跑与状态筛查

#	姓名/编号	起跑序位	目标配速/km	跑步LTHR	睡眠1-5	腿酸1-5	疼痛/部位	状态1-5	实际起跑
1									
2									
3									
4									
5									
6									

起跑间隔与器械检查

间隔	学员1	学员2	学员3	学员4	学员5	学员6	教练判断
75秒	0:00	1:15	2:30	3:45	5:00	6:15	Ski或其他单通道占用>75秒时不可用
90秒	0:00	1:30	3:00	4:30	6:00	7:30	或增加第二台器械，避免排队污染

☐ 雪橇总负重: 推_____kg / 拉_____kg ☐ 雪橇编号: _____ ☐ 草皮/摩擦面: _____

☐ Ski: 台号____ 阻尼____ ☐ Wall Ball: _____kg / 高度____ ☐ 环境: _____℃ / 湿度_____

☐ 距离与路线已测量 ☐ 计时器/手表同步 ☐ 两次Lap已讲解 ☐ 动作标准已示范

☐ 急救设备/流程已确认 ☐ 污染标记规则已讲解 ☐ 不追加惩罚训练

六人结果与后续计划总览

先填各自双页记录，再回填本表

#	姓名	跑损%	站损%	最大站后变化	ΔHR	配速标志	限制类型	session-RPE AU	复测日期
1									
2									
3									
4									
5									
6									

姓名/编号		日期		组别		起跑时间	
预计比赛配速/km		本课目标配速/km		跑步LTHR		目标R1 800m	

课前状态与安全筛查

睡眠1-5	腿部酸痛1-5	今日状态1-5	疼痛/部位	近期急性病/伤	教练决定
				☐ 无 ☐ 有:_____	☐ 参加 ☐ 降级 ☐ 不参加
症状核对	☐ 胸痛/压迫 ☐ 晕厥/近晕厥 ☐ 异常严重气短 ☐ 意识/协调异常 ☐ 锐痛 ☐ 动作失控				任一出现: 立即停止并启动现场应急流程

复测条件

雪橇推总重 _____ kg	雪橇拉总重 _____ kg	雪橇/草皮 _____	Ski台号/阻尼 _____	Wall Ball _____ kg / 高度_____	环境 _____ °C / 湿度_____
-------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------------------	--------------------------

4轮原始记录

每轮即时RPE与课后整体session-RPE分开记录

轮次	800m时间	折算配速/km	站点总时间	跑步平均HR	即时RPE	污染	技术异常/排队/器械变化
R1 基准						☐	
R2						☐	
R3 晚段						☐	
R4 晚段						☐	

计算与判断证据

晚段跑步均值 (R3+R4)/2 = _____	诊断课跑损 (晚段/R1-1)×100 = _____ %	晚段站点均值 (R3+R4)/2 = _____	诊断课站损 (晚段/R1-1)×100 = _____ %
R1站后→R2跑 (R2/R1-1)×100 = _____ %	R2站后→R3跑 (R3/R2-1)×100 = _____ %	R3站后→R4跑 (R4/R3-1)×100 = _____ %	ΔHR 平均(HR3,HR4)-HR1 = _____ bpm
课后20-30分钟整体session-RPE: _____ /10	实际完成时长: _____ 分钟	内部负荷: session-RPE × 实际分钟 = _____ AU	数据结论: ☐ 可分类 ☐ 受污染仅描述

证据摘要与限制类型

跑损等级 □ ≤3%稳定 □ >3-6%中度 □ >6%高	站损等级 □ ≤5%稳定 □ >5-10%中度 □ >10%高	首轮配速 □ 合规 □ 快>5秒/km □ R1 RPE≥8	数据质量 □ 干净 □ 有污染 □ 条件不可比
正式判断: □ 混合耐力稳定 □ 跑步受限 □ 站点受限 □ 综合混合耐力受限 □ 疑似配速策略问题 □ 暂不分类			session-RPE负荷: _____ AU

完整训练处方库

只勾选与本次证据一致的主处方；配速或污染问题先复测

选择	适用判断	未来2-4周主处方	监控与停止线
☐	疑似配速问题	相同课表按合规R1配速复测；R1对齐本课目标，前三轮目标±5秒/km（800m为±4秒），第四轮不以最后200m冲刺掩盖前段崩溃。暂不增加阈值课或站点负荷。	监控R1折算配速、R1 RPE、跑损和站损；合规复测后再决定生理短板。
☐	混合耐力稳定	下一次只增加一个变量：800m升级到1km，或站点总量约+10%；不要同时增加速度、负重和总量。	维持动作标准；2-4周同条件复测。任何一项损耗跨级时停止继续加量。
☐	跑步受限	每周1次4-5组（60-75秒标准站点 + 800m目标配速跑），组间2分钟，要求跑损≤3%；另保留1次3×8分钟阈值跑，组间慢跑2分钟，以有效跑步CS/LTHR/Talk Test锚定。	混合课与阈值课错开；监控每组800m、RPE、动作与次日恢复。跑损持续>6%或动作崩溃时降量。
☐	站点受限	每周1次同站点重复：6-8组×60-90秒，组间90秒，保持比赛负重和动作标准。若有站点分段/明确异常，再拆分雪橇起步与转向、BBJ节律或Wall Ball呼吸。	相对第一组有效成绩损耗>7%或动作变形时停止（SSP内部技术质量线）。无单站证据时不得武断指定具体站点。
☐	综合混合耐力受限	站点量或负重降低10-15%；3组（1km目标配速慢10-15秒 + 2分钟站点），组间2-3分钟；保留每周两次低强度有氧，暂不增加全力模拟赛。	监控睡眠、疼痛、session-RPE、动作和后程损耗；当天状态差时先恢复，不把疲劳误判为能力不足。
☐	数据污染/条件不可比	维持原计划；按同一雪橇、草皮、Ski、Wall Ball、路线、计时和起跑间隔完成干净复测。	本次只描述，不加量、不减量、不做医疗判断。

个体周计划与监控

周次	主课（处方/组数/配速或负重）	第二关键课	低强有氧/力量	恢复与监控	完成/异常
第1周					
第2周					
第3周					
第4周/复测					

复测日期: _____ 同条件: □ 是 □ 否 目标: 跑损≤ _____ % / 站损≤ _____ % / 技术目标 _____	教练签名: _____ 学员反馈: _____
复测后决策: □ 维持 □ 单变量加量 □ 继续原处方 □ 调整方向 □ 转介专业评估	备注: _____

姓名/编号		日期		组别		起跑时间	
预计比赛配速/km		本课目标配速/km		跑步LTHR		目标R1 800m	

课前状态与安全筛查

睡眠1-5	腿部酸痛1-5	今日状态1-5	疼痛/部位	近期急性病/伤	教练决定
				☐ 无 ☐ 有:_____	☐ 参加 ☐ 降级 ☐ 不参加
症状核对	☐ 胸痛/压迫 ☐ 晕厥/近晕厥 ☐ 异常严重气短 ☐ 意识/协调异常 ☐ 锐痛 ☐ 动作失控				任一出现: 立即停止并启动现场应急流程

复测条件

雪橇推总重 _____ kg	雪橇拉总重 _____ kg	雪橇/草皮 _____	Ski台号/阻尼 _____	Wall Ball _____ kg / 高度_____	环境 _____ °C / 湿度_____
-------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------------------	--------------------------

4轮原始记录

每轮即时RPE与课后整体session-RPE分开记录

轮次	800m时间	折算配速/km	站点总时间	跑步平均HR	即时RPE	污染	技术异常/排队/器械变化
R1 基准						☐	
R2						☐	
R3 晚段						☐	
R4 晚段						☐	

计算与判断证据

晚段跑步均值 (R3+R4)/2 = _____	诊断课跑损 (晚段/R1-1)×100 = _____ %	晚段站点均值 (R3+R4)/2 = _____	诊断课站损 (晚段/R1-1)×100 = _____ %
R1站后→R2跑 (R2/R1-1)×100 = _____ %	R2站后→R3跑 (R3/R2-1)×100 = _____ %	R3站后→R4跑 (R4/R3-1)×100 = _____ %	ΔHR 平均(HR3,HR4)-HR1 = _____ bpm
课后20-30分钟整体session-RPE: _____ /10	实际完成时长: _____ 分钟	内部负荷: session-RPE × 实际分钟 = _____ AU	数据结论: ☐ 可分类 ☐ 受污染仅描述

证据摘要与限制类型

跑损等级 □ ≤3%稳定 □ >3-6%中度 □ >6%高	站损等级 □ ≤5%稳定 □ >5-10%中度 □ >10%高	首轮配速 □ 合规 □ 快>5秒/km □ R1 RPE≥8	数据质量 □ 干净 □ 有污染 □ 条件不可比
正式判断: □ 混合耐力稳定 □ 跑步受限 □ 站点受限 □ 综合混合耐力受限 □ 疑似配速策略问题 □ 暂不分类			session-RPE负荷: _____ AU

完整训练处方库

只勾选与本次证据一致的主处方；配速或污染问题先复测

选择	适用判断	未来2-4周主处方	监控与停止线
□	疑似配速问题	相同课表按合规R1配速复测；R1对齐本课目标，前三轮目标±5秒/km（800m为±4秒），第四轮不以最后200m冲刺掩盖前段崩溃。暂不增加阈值课或站点负荷。	监控R1折算配速、R1 RPE、跑损和站损；合规复测后再决定生理短板。
□	混合耐力稳定	下一次只增加一个变量：800m升级到1km，或站点总量约+10%；不要同时增加速度、负重和总量。	维持动作标准；2-4周同条件复测。任何一项损耗跨级时停止继续加量。
□	跑步受限	每周1次4-5组（60-75秒标准站点 + 800m目标配速跑），组间2分钟，要求跑损≤3%；另保留1次3×8分钟阈值跑，组间慢跑2分钟，以有效跑步CS/LTHR/Talk Test锚定。	混合课与阈值课错开；监控每组800m、RPE、动作与次日恢复。跑损持续>6%或动作崩溃时降量。
□	站点受限	每周1次同站点重复：6-8组×60-90秒，组间90秒，保持比赛负重和动作标准。若有站点分段/明确异常，再拆分雪橇起步与转向、BBJ节律或Wall Ball呼吸。	相对第一组有效成绩损耗>7%或动作变形时停止（SSP内部技术质量线）。无单站证据时不得武断指定具体站点。
□	综合混合耐力受限	站点量或负重降低10-15%；3组（1km目标配速慢10-15秒 + 2分钟站点），组间2-3分钟；保留每周两次低强度有氧，暂不增加全力模拟赛。	监控睡眠、疼痛、session-RPE、动作和后程损耗；当天状态差时先恢复，不把疲劳误判为能力不足。
□	数据污染/条件不可比	维持原计划；按同一雪橇、草皮、Ski、Wall Ball、路线、计时和起跑间隔完成干净复测。	本次只描述，不加量、不减量、不做医疗判断。

个体周计划与监控

周次	主课（处方/组数/配速或负重）	第二关键课	低强有氧/力量	恢复与监控	完成/异常
第1周					
第2周					
第3周					
第4周/复测					

复测日期: _____ 同条件: □ 是 □ 否 目标: 跑损≤ _____ % / 站损≤ _____ % / 技术目标 _____	教练签名: _____ 学员反馈: _____
复测后决策: □ 维持 □ 单变量加量 □ 继续原处方 □ 调整方向 □ 转介专业评估	备注: _____

姓名/编号		日期		组别		起跑时间	
预计比赛配速/km		本课目标配速/km		跑步LTHR		目标R1 800m	

课前状态与安全筛查

睡眠1-5	腿部酸痛1-5	今日状态1-5	疼痛/部位	近期急性病/伤	教练决定
				☐ 无 ☐ 有:_____	☐ 参加 ☐ 降级 ☐ 不参加
症状核对	☐ 胸痛/压迫 ☐ 晕厥/近晕厥 ☐ 异常严重气短 ☐ 意识/协调异常 ☐ 锐痛 ☐ 动作失控				任一出现: 立即停止并启动现场应急流程

复测条件

雪橇推总重 _____ kg	雪橇拉总重 _____ kg	雪橇/草皮 _____	Ski台号/阻尼 _____	Wall Ball _____ kg / 高度_____	环境 _____ °C / 湿度_____
-------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------------------	--------------------------

4轮原始记录

每轮即时RPE与课后整体session-RPE分开记录

轮次	800m时间	折算配速/km	站点总时间	跑步平均HR	即时RPE	污染	技术异常/排队/器械变化
R1 基准						☐	
R2						☐	
R3 晚段						☐	
R4 晚段						☐	

计算与判断证据

晚段跑步均值 (R3+R4)/2 = _____	诊断课跑损 (晚段/R1-1)×100 = _____ %	晚段站点均值 (R3+R4)/2 = _____	诊断课站损 (晚段/R1-1)×100 = _____ %
R1站后→R2跑 (R2/R1-1)×100 = _____ %	R2站后→R3跑 (R3/R2-1)×100 = _____ %	R3站后→R4跑 (R4/R3-1)×100 = _____ %	ΔHR 平均(HR3,HR4)-HR1 = _____ bpm
课后20-30分钟整体session-RPE: _____ /10	实际完成时长: _____ 分钟	内部负荷: session-RPE × 实际分钟 = _____ AU	数据结论: ☐ 可分类 ☐ 受污染仅描述

证据摘要与限制类型

跑损等级 □ ≤3%稳定 □ >3-6%中度 □ >6%高	站损等级 □ ≤5%稳定 □ >5-10%中度 □ >10%高	首轮配速 □ 合规 □ 快>5秒/km □ R1 RPE≥8	数据质量 □ 干净 □ 有污染 □ 条件不可比
正式判断: □ 混合耐力稳定 □ 跑步受限 □ 站点受限 □ 综合混合耐力受限 □ 疑似配速策略问题 □ 暂不分类			session-RPE负荷: _____ AU

完整训练处方库

只勾选与本次证据一致的主处方；配速或污染问题先复测

选择	适用判断	未来2-4周主处方	监控与停止线
☐	疑似配速问题	相同课表按合规R1配速复测；R1对齐本课目标，前三轮目标±5秒/km（800m为±4秒），第四轮不以最后200m冲刺掩盖前段崩溃。暂不增加阈值课或站点负荷。	监控R1折算配速、R1 RPE、跑损和站损；合规复测后再决定生理短板。
☐	混合耐力稳定	下一次只增加一个变量：800m升级到1km，或站点总量约+10%；不要同时增加速度、负重和总量。	维持动作标准；2-4周同条件复测。任何一项损耗跨级时停止继续加量。
☐	跑步受限	每周1次4-5组（60-75秒标准站点 + 800m目标配速跑），组间2分钟，要求跑损≤3%；另保留1次3×8分钟阈值跑，组间慢跑2分钟，以有效跑步CS/LTHR/Talk Test锚定。	混合课与阈值课错开；监控每组800m、RPE、动作与次日恢复。跑损持续>6%或动作崩溃时降量。
☐	站点受限	每周1次同站点重复：6-8组×60-90秒，组间90秒，保持比赛负重和动作标准。若有站点分段/明确异常，再拆分雪橇起步与转向、BBJ节律或Wall Ball呼吸。	相对第一组有效成绩损耗>7%或动作变形时停止（SSP内部技术质量线）。无单站证据时不得武断指定具体站点。
☐	综合混合耐力受限	站点量或负重降低10-15%；3组（1km目标配速慢10-15秒 + 2分钟站点），组间2-3分钟；保留每周两次低强度有氧，暂不增加全力模拟赛。	监控睡眠、疼痛、session-RPE、动作和后程损耗；当天状态差时先恢复，不把疲劳误判为能力不足。
☐	数据污染/条件不可比	维持原计划；按同一雪橇、草皮、Ski、Wall Ball、路线、计时和起跑间隔完成干净复测。	本次只描述，不加量、不减量、不做医疗判断。

个体周计划与监控

周次	主课（处方/组数/配速或负重）	第二关键课	低强有氧/力量	恢复与监控	完成/异常
第1周					
第2周					
第3周					
第4周/复测					

复测日期: _____ 同条件: □ 是 □ 否 目标: 跑损≤ _____ % / 站损≤ _____ % / 技术目标 _____	教练签名: _____ 学员反馈: _____
复测后决策: □ 维持 □ 单变量加量 □ 继续原处方 □ 调整方向 □ 转介专业评估	备注: _____

姓名/编号		日期		组别		起跑时间	
预计比赛配速/km		本课目标配速/km		跑步LTHR		目标R1 800m	

课前状态与安全筛查

睡眠1-5	腿部酸痛1-5	今日状态1-5	疼痛/部位	近期急性病/伤	教练决定
				☐ 无 ☐ 有:_____	☐ 参加 ☐ 降级 ☐ 不参加
症状核对	☐ 胸痛/压迫 ☐ 晕厥/近晕厥 ☐ 异常严重气短 ☐ 意识/协调异常 ☐ 锐痛 ☐ 动作失控				任一出现: 立即停止并启动现场应急流程

复测条件

雪橇推总重 _____ kg	雪橇拉总重 _____ kg	雪橇/草皮 _____	Ski台号/阻尼 _____	Wall Ball _____ kg / 高度_____	环境 _____ °C / 湿度_____
-------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------------------	--------------------------

4轮原始记录

每轮即时RPE与课后整体session-RPE分开记录

轮次	800m时间	折算配速/km	站点总时间	跑步平均HR	即时RPE	污染	技术异常/排队/器械变化
R1 基准						☐	
R2						☐	
R3 晚段						☐	
R4 晚段						☐	

计算与判断证据

晚段跑步均值 (R3+R4)/2 = _____	诊断课跑损 (晚段/R1-1)×100 = _____ %	晚段站点均值 (R3+R4)/2 = _____	诊断课站损 (晚段/R1-1)×100 = _____ %
R1站后→R2跑 (R2/R1-1)×100 = _____ %	R2站后→R3跑 (R3/R2-1)×100 = _____ %	R3站后→R4跑 (R4/R3-1)×100 = _____ %	ΔHR 平均(HR3,HR4)-HR1 = _____ bpm
课后20-30分钟整体session-RPE: _____ /10	实际完成时长: _____ 分钟	内部负荷: session-RPE × 实际分钟 = _____ AU	数据结论: ☐ 可分类 ☐ 受污染仅描述

证据摘要与限制类型

跑损等级 □ ≤3%稳定 □ >3-6%中度 □ >6%高	站损等级 □ ≤5%稳定 □ >5-10%中度 □ >10%高	首轮配速 □ 合规 □ 快>5秒/km □ R1 RPE≥8	数据质量 □ 干净 □ 有污染 □ 条件不可比
正式判断: □ 混合耐力稳定 □ 跑步受限 □ 站点受限 □ 综合混合耐力受限 □ 疑似配速策略问题 □ 暂不分类			session-RPE负荷: _____ AU

完整训练处方库

只勾选与本次证据一致的主处方；配速或污染问题先复测

选择	适用判断	未来2-4周主处方	监控与停止线
☐	疑似配速问题	相同课表按合规R1配速复测；R1对齐本课目标，前三轮目标±5秒/km（800m为±4秒），第四轮不以最后200m冲刺掩盖前段崩溃。暂不增加阈值课或站点负荷。	监控R1折算配速、R1 RPE、跑损和站损；合规复测后再决定生理短板。
☐	混合耐力稳定	下一次只增加一个变量：800m升级到1km，或站点总量约+10%；不要同时增加速度、负重和总量。	维持动作标准；2-4周同条件复测。任何一项损耗跨级时停止继续加量。
☐	跑步受限	每周1次4-5组（60-75秒标准站点 + 800m目标配速跑），组间2分钟，要求跑损≤3%；另保留1次3×8分钟阈值跑，组间慢跑2分钟，以有效跑步CS/LTHR/Talk Test锚定。	混合课与阈值课错开；监控每组800m、RPE、动作与次日恢复。跑损持续>6%或动作崩溃时降量。
☐	站点受限	每周1次同站点重复：6-8组×60-90秒，组间90秒，保持比赛负重和动作标准。若有站点分段/明确异常，再拆分雪橇起步与转向、BBJ节律或Wall Ball呼吸。	相对第一组有效成绩损耗>7%或动作变形时停止（SSP内部技术质量线）。无单站证据时不得武断指定具体站点。
☐	综合混合耐力受限	站点量或负重降低10-15%；3组（1km目标配速慢10-15秒 + 2分钟站点），组间2-3分钟；保留每周两次低强度有氧，暂不增加全力模拟赛。	监控睡眠、疼痛、session-RPE、动作和后程损耗；当天状态差时先恢复，不把疲劳误判为能力不足。
☐	数据污染/条件不可比	维持原计划；按同一雪橇、草皮、Ski、Wall Ball、路线、计时和起跑间隔完成干净复测。	本次只描述，不加量、不减量、不做医疗判断。

个体周计划与监控

周次	主课（处方/组数/配速或负重）	第二关键课	低强有氧/力量	恢复与监控	完成/异常
第1周					
第2周					
第3周					
第4周/复测					

复测日期: _____ 同条件: □ 是 □ 否 目标: 跑损≤ _____ % / 站损≤ _____ % / 技术目标 _____	教练签名: _____ 学员反馈: _____
复测后决策: □ 维持 □ 单变量加量 □ 继续原处方 □ 调整方向 □ 转介专业评估	备注: _____

姓名/编号		日期		组别		起跑时间	
预计比赛配速/km		本课目标配速/km		跑步LTHR		目标R1 800m	

课前状态与安全筛查

睡眠1-5	腿部酸痛1-5	今日状态1-5	疼痛/部位	近期急性病/伤	教练决定
				☐ 无 ☐ 有:_____	☐ 参加 ☐ 降级 ☐ 不参加
症状核对	☐ 胸痛/压迫 ☐ 晕厥/近晕厥 ☐ 异常严重气短 ☐ 意识/协调异常 ☐ 锐痛 ☐ 动作失控				任一出现: 立即停止并启动现场应急流程

复测条件

雪橇推总重 _____ kg	雪橇拉总重 _____ kg	雪橇/草皮 _____	Ski台号/阻尼 _____	Wall Ball _____ kg / 高度_____	环境 _____ °C / 湿度_____
-------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------------------	--------------------------

4轮原始记录

每轮即时RPE与课后整体session-RPE分开记录

轮次	800m时间	折算配速/km	站点总时间	跑步平均HR	即时RPE	污染	技术异常/排队/器械变化
R1 基准						☐	
R2						☐	
R3 晚段						☐	
R4 晚段						☐	

计算与判断证据

晚段跑步均值 (R3+R4)/2 = _____	诊断课跑损 (晚段/R1-1)×100 = _____ %	晚段站点均值 (R3+R4)/2 = _____	诊断课站损 (晚段/R1-1)×100 = _____ %
R1站后→R2跑 (R2/R1-1)×100 = _____ %	R2站后→R3跑 (R3/R2-1)×100 = _____ %	R3站后→R4跑 (R4/R3-1)×100 = _____ %	ΔHR 平均(HR3,HR4)-HR1 = _____ bpm
课后20-30分钟整体session-RPE: _____ /10	实际完成时长: _____ 分钟	内部负荷: session-RPE × 实际分钟 = _____ AU	数据结论: ☐ 可分类 ☐ 受污染仅描述

证据摘要与限制类型

跑损等级 □ ≤3%稳定 □ >3-6%中度 □ >6%高	站损等级 □ ≤5%稳定 □ >5-10%中度 □ >10%高	首轮配速 □ 合规 □ 快>5秒/km □ R1 RPE≥8	数据质量 □ 干净 □ 有污染 □ 条件不可比
正式判断: □ 混合耐力稳定 □ 跑步受限 □ 站点受限 □ 综合混合耐力受限 □ 疑似配速策略问题 □ 暂不分类			session-RPE负荷: _____ AU

完整训练处方库

只勾选与本次证据一致的主处方；配速或污染问题先复测

选择	适用判断	未来2-4周主处方	监控与停止线
☐	疑似配速问题	相同课表按合规R1配速复测；R1对齐本课目标，前三轮目标±5秒/km（800m为±4秒），第四轮不以最后200m冲刺掩盖前段崩溃。暂不增加阈值课或站点负荷。	监控R1折算配速、R1 RPE、跑损和站损；合规复测后再决定生理短板。
☐	混合耐力稳定	下一次只增加一个变量：800m升级到1km，或站点总量约+10%；不要同时增加速度、负重和总量。	维持动作标准；2-4周同条件复测。任何一项损耗跨级时停止继续加量。
☐	跑步受限	每周1次4-5组（60-75秒标准站点 + 800m目标配速跑），组间2分钟，要求跑损≤3%；另保留1次3×8分钟阈值跑，组间慢跑2分钟，以有效跑步CS/LTHR/Talk Test锚定。	混合课与阈值课错开；监控每组800m、RPE、动作与次日恢复。跑损持续>6%或动作崩溃时降量。
☐	站点受限	每周1次同站点重复：6-8组×60-90秒，组间90秒，保持比赛负重和动作标准。若有站点分段/明确异常，再拆分雪橇起步与转向、BBJ节律或Wall Ball呼吸。	相对第一组有效成绩损耗>7%或动作变形时停止（SSP内部技术质量线）。无单站证据时不得武断指定具体站点。
☐	综合混合耐力受限	站点量或负重降低10-15%；3组（1km目标配速慢10-15秒 + 2分钟站点），组间2-3分钟；保留每周两次低强度有氧，暂不增加全力模拟赛。	监控睡眠、疼痛、session-RPE、动作和后程损耗；当天状态差时先恢复，不把疲劳误判为能力不足。
☐	数据污染/条件不可比	维持原计划；按同一雪橇、草皮、Ski、Wall Ball、路线、计时和起跑间隔完成干净复测。	本次只描述，不加量、不减量、不做医疗判断。

个体周计划与监控

周次	主课（处方/组数/配速或负重）	第二关键课	低强有氧/力量	恢复与监控	完成/异常
第1周					
第2周					
第3周					
第4周/复测					

复测日期: _____ 同条件: □ 是 □ 否 目标: 跑损≤ _____ % / 站损≤ _____ % / 技术目标 _____	教练签名: _____ 学员反馈: _____
复测后决策: □ 维持 □ 单变量加量 □ 继续原处方 □ 调整方向 □ 转介专业评估	备注: _____

姓名/编号		日期		组别		起跑时间	
预计比赛配速/km		本课目标配速/km		跑步LTHR		目标R1 800m	

课前状态与安全筛查

睡眠1-5	腿部酸痛1-5	今日状态1-5	疼痛/部位	近期急性病/伤	教练决定
				☐ 无 ☐ 有:_____	☐ 参加 ☐ 降级 ☐ 不参加
症状核对	☐ 胸痛/压迫 ☐ 晕厥/近晕厥 ☐ 异常严重气短 ☐ 意识/协调异常 ☐ 锐痛 ☐ 动作失控				任一出现: 立即停止并启动现场应急流程

复测条件

雪橇推总重 _____ kg	雪橇拉总重 _____ kg	雪橇/草皮 _____	Ski台号/阻尼 _____	Wall Ball _____ kg / 高度_____	环境 _____ °C / 湿度_____
-------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------------------	--------------------------

4轮原始记录

每轮即时RPE与课后整体session-RPE分开记录

轮次	800m时间	折算配速/km	站点总时间	跑步平均HR	即时RPE	污染	技术异常/排队/器械变化
R1 基准						☐	
R2						☐	
R3 晚段						☐	
R4 晚段						☐	

计算与判断证据

晚段跑步均值 (R3+R4)/2 = _____	诊断课跑损 (晚段/R1-1)×100 = _____ %	晚段站点均值 (R3+R4)/2 = _____	诊断课站损 (晚段/R1-1)×100 = _____ %
R1站后→R2跑 (R2/R1-1)×100 = _____ %	R2站后→R3跑 (R3/R2-1)×100 = _____ %	R3站后→R4跑 (R4/R3-1)×100 = _____ %	ΔHR 平均(HR3,HR4)-HR1 = _____ bpm
课后20-30分钟整体session-RPE: _____ /10	实际完成时长: _____ 分钟	内部负荷: session-RPE × 实际分钟 = _____ AU	数据结论: ☐ 可分类 ☐ 受污染仅描述

证据摘要与限制类型

跑损等级 □ ≤3%稳定 □ >3-6%中度 □ >6%高	站损等级 □ ≤5%稳定 □ >5-10%中度 □ >10%高	首轮配速 □ 合规 □ 快>5秒/km □ R1 RPE≥8	数据质量 □ 干净 □ 有污染 □ 条件不可比
正式判断: □ 混合耐力稳定 □ 跑步受限 □ 站点受限 □ 综合混合耐力受限 □ 疑似配速策略问题 □ 暂不分类			session-RPE负荷: _____ AU

完整训练处方库

只勾选与本次证据一致的主处方；配速或污染问题先复测

选择	适用判断	未来2-4周主处方	监控与停止线
☐	疑似配速问题	相同课表按合规R1配速复测；R1对齐本课目标，前三轮目标±5秒/km（800m为±4秒），第四轮不以最后200m冲刺掩盖前段崩溃。暂不增加阈值课或站点负荷。	监控R1折算配速、R1 RPE、跑损和站损；合规复测后再决定生理短板。
☐	混合耐力稳定	下一次只增加一个变量：800m升级到1km，或站点总量约+10%；不要同时增加速度、负重和总量。	维持动作标准；2-4周同条件复测。任何一项损耗跨级时停止继续加量。
☐	跑步受限	每周1次4-5组（60-75秒标准站点 + 800m目标配速跑），组间2分钟，要求跑损≤3%；另保留1次3×8分钟阈值跑，组间慢跑2分钟，以有效跑步CS/LTHR/Talk Test锚定。	混合课与阈值课错开；监控每组800m、RPE、动作与次日恢复。跑损持续>6%或动作崩溃时降量。
☐	站点受限	每周1次同站点重复：6-8组×60-90秒，组间90秒，保持比赛负重和动作标准。若有站点分段/明确异常，再拆分雪橇起步与转向、BBJ节律或Wall Ball呼吸。	相对第一组有效成绩损耗>7%或动作变形时停止（SSP内部技术质量线）。无单站证据时不得武断指定具体站点。
☐	综合混合耐力受限	站点量或负重降低10-15%；3组（1km目标配速慢10-15秒 + 2分钟站点），组间2-3分钟；保留每周两次低强度有氧，暂不增加全力模拟赛。	监控睡眠、疼痛、session-RPE、动作和后程损耗；当天状态差时先恢复，不把疲劳误判为能力不足。
☐	数据污染/条件不可比	维持原计划；按同一雪橇、草皮、Ski、Wall Ball、路线、计时和起跑间隔完成干净复测。	本次只描述，不加量、不减量、不做医疗判断。

个体周计划与监控

周次	主课（处方/组数/配速或负重）	第二关键课	低强有氧/力量	恢复与监控	完成/异常
第1周					
第2周					
第3周					
第4周/复测					

复测日期: _____ 同条件: □ 是 □ 否 目标: 跑损≤ _____ % / 站损≤ _____ % / 技术目标 _____	教练签名: _____ 学员反馈: _____
复测后决策: □ 维持 □ 单变量加量 □ 继续原处方 □ 调整方向 □ 转介专业评估	备注: _____